

Il latte materno

Lettura graduata per imparare l'italiano - livelli A1-C1



Il testo è in italiano. Sotto ogni brano trovi le parole utili con la traduzione e le domande: scrivi le risposte nei riquadri.

A1 - A2 - B1 - B2 - C1

<https://italianoconmartin.com/letture/latte-materno.html>

Il latte materno - livello A1

Presente

Il latte materno è quasi tutto acqua: 87 parti su 100. Ma dentro ci sono più di duecento sostanze diverse.

Il latte cambia durante la poppata. All'inizio è leggero. Alla fine ha più grassi, e il bambino si sente sazio.

Il latte cambia anche con l'ora. Di notte ha più melatonina, l'ormone del sonno. Di giorno ha più cortisolo, e il bambino resta sveglio.

Nel latte ci sono più di duecento zuccheri che il bambino non digerisce. Non sono per lui: sono il cibo dei batteri buoni del suo intestino.

Quando la madre o il bambino sono malati, nel latte arrivano molti globuli bianchi. Sono le cellule che difendono dalle malattie.

Nei primi giorni la madre produce il colostro: poco, circa 30 millilitri al giorno. Ma anche lo stomaco del neonato è piccolo e tiene solo 5 millilitri.

Parole utili

poppata
grassi
sazio
sveglia
colostro

Domande

1. Quando il latte ha più grassi?

2. Che cosa c'è di più nel latte di notte?

3. Quanto latte tiene lo stomaco del neonato?

Il latte materno - livello A2

Descrivere cambiamenti

Il latte materno sembra un liquido semplice, ma non lo è. È acqua per l'87 per cento; in quello che resta ci sono più di duecento sostanze diverse.

Durante una poppata il latte cambia: all'inizio è più leggero, alla fine contiene più grassi. Per questo il bambino si sente sazio e smette di bere.

Cambia anche con l'ora del giorno. Di notte contiene più melatonina, l'ormone del sonno; di giorno contiene più cortisolo, che aiuta a stare svegli.

Più di duecento zuccheri del latte non servono al bambino, perché lui non riesce a digerirli. Servono ai batteri buoni che vivono nel suo intestino: li mangiano e crescono.

Se la madre o il bambino prendono un'infezione, nel latte aumentano i globuli bianchi, cioè le cellule che combattono le malattie. Quando la malattia passa, tornano come prima.

Nei primi giorni c'è il colostro: circa 30 millilitri al giorno, quindi molto poco. Ma va bene così, perché lo stomaco del neonato tiene solo 5 millilitri per volta.

Parole utili

infezione

digerire

intestino

aumentare

stomaco

Domande

1. Perché il bambino smette di bere alla fine della poppata?

2. A chi servono gli zuccheri che il bambino non digerisce?

3. Che cosa succede ai globuli bianchi quando c'è un'infezione?

Il latte materno - livello B1

Spiegare funzioni

Il latte materno è composto per l'87 per cento di acqua, ma nel resto contiene più di duecento sostanze diverse. Non è un liquido fisso: cambia continuamente.

Cambia durante la stessa poppata. All'inizio è più leggero, alla fine è più grasso: è il grasso finale che dà al bambino la sensazione di sazietà e gli fa capire quando fermarsi.

Cambia anche con l'ora. Di notte contiene più melatonina, l'ormone che favorisce il sonno, mentre di giorno contiene più cortisolo, che tiene svegli. In pratica il latte aiuta il bambino a costruire il ritmo tra il giorno e la notte.

Più di duecento zuccheri del latte non vengono digeriti dal bambino. Sembra uno spreco, ma non lo è: nutrono i batteri utili del suo intestino e funzionano anche da esca, perché i germi si attaccano a loro invece che alla parete dell'intestino.

Quando la madre o il bambino si ammalano, la quantità di globuli bianchi nel latte cresce in poche ore, e con la guarigione ritorna al livello di prima. È una difesa che si accende quando serve.

Nei primi giorni la madre produce solo il colostro: circa 30 millilitri al giorno. La quantità è piccola, ma corrisponde a quello che lo stomaco del neonato riesce a contenere, cioè circa 5 millilitri per volta.

Parole utili

sazietà

esca

parete

guarigione

contenere

Domande

1. In che modo il latte aiuta il bambino a distinguere il giorno dalla notte?

2. Come funzionano gli zuccheri che fanno da esca?

3. Perché la piccola quantità di colostro non è un problema?

Il latte materno - livello B2

Leggere dati e relazioni

Considerare il latte materno un liquido sempre uguale è un errore. È acqua per l'87 per cento, ma le sostanze restanti sono più di duecento e la loro proporzione non rimane mai identica.

La composizione si modifica nel corso della stessa poppata: la parte iniziale è più leggera, quella finale più ricca di grassi. La sazietà arriva quindi in un momento preciso e non dipende dal volume bevuto.

Anche l'ora conta. Di notte aumenta la melatonina, l'ormone legato al sonno; di giorno prevale il cortisolo, associato alla veglia. Il latte trasmette così un'informazione sul tempo, oltre che nutrimento.

Oltre duecento zuccheri attraversano l'intestino del bambino senza essere digeriti. Non sono destinati a lui, ma ai batteri che lo popolano; in più assomigliano ai punti di aggancio della parete intestinale, e i germi si legano a loro invece che alle cellule.

Il cambiamento più netto riguarda le difese. In condizioni normali i globuli bianchi sono tra lo 0 e il 2 per cento delle cellule del latte; durante un'infezione della madre o del bambino la quota sale rapidamente, fino al 94 per cento nei casi misurati, per poi tornare al valore iniziale.

Lo stesso criterio vale all'inizio. Il colostro dei primi giorni è di circa 30 millilitri quotidiani: sembra poco, ma lo stomaco di un neonato ne contiene circa 5 per volta. La quantità non è scarsa, è calibrata.

Parole utili

composizione
proporzione
quota
aggancio
calibrata

Domande

1. Perché si dice che la sazietà non dipende dal volume bevuto?

2. Che cosa cambia nel latte durante un'infezione, e con quali numeri?

3. In che senso la quantità di colostro è calibrata e non scarsa?

Il latte materno - livello C1

Analisi scientifica

Definire il latte materno un alimento è riduttivo. L'acqua ne costituisce l'87 per cento, ma le oltre duecento sostanze restanti svolgono tre lavori distinti: nutrire, informare e difendere.

La variazione avviene già all'interno di una singola poppata, dove al liquido iniziale più leggero subentra una frazione più grassa: la sazietà è dunque un segnale, non una questione di volume.

Su scala giornaliera interviene il ritmo ormonale. La melatonina notturna e il cortisolo diurno accompagnano l'alternanza fra sonno e veglia, e il latte finisce per trasmettere anche l'ora del giorno.

Più singolare è il destino degli oltre duecento zuccheri che il bambino non è in grado di digerire. Non sono rivolti a lui ma alla flora del suo intestino, e la loro somiglianza con i punti di aggancio della parete intestinale li rende esche: i germi vi si legano e vengono eliminati.

La componente immunitaria è la più reattiva. La quota di globuli bianchi, normalmente compresa fra lo 0 e il 2 per cento delle cellule, sale fino al 94 per cento durante un'infezione della madre o del solo bambino, e rientra con la guarigione: una difesa che si accende su richiesta.

Perfino la scarsità iniziale è calcolata. Ai 30 millilitri quotidiani di colostro corrisponde uno stomaco che ne accoglie 5 per volta. Il latte artificiale riproduce le calorie e le proteine, non questa dinamica: resta una fotografia dove il latte materno è una conversazione.

Parole utili

riduttivo
subentrare
alternanza
somiglianza
accogliere

Domande

1. Quali sono i tre lavori che il latte materno svolge insieme?

2. Perché gli zuccheri non digeribili non sono uno spreco?

3. Che cosa distingue una «fotografia» da una «conversazione», nel confronto con il latte artificiale?

Lezioni di italiano 1:1



Martin

scienza, tecnologia ed etimologia

[Prenota su Preply](#)



Licia

arte, pazienza e grammatica

[Prenota su Preply](#)

italianoconmartin.com - letture, grammatica e vocabolario gratuiti